

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE COMPORTAMIENTO AGITADO DE CORRIGAN (ABS)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Cuantificación de Agitación Psicomotriz, Amnesia Postraumática y Delirium

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Comportamiento Agitado de Corrigan (ABS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Agitated Behavior Scale (ABS)</i>
Autor del Diseño Original	Dr. John D. Corrigan (1989), <i>The Ohio State University</i> , EE. UU.
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación observacional estandarizada de agitación aguda en neurorehabilitación.
Modalidad de Aplicación	Heteroaplicada por observación directa estructurada (personal médico, de enfermería o neuropsicología).
Población Objetivo	Adultos y adolescentes con Traumatismo Craneoencefálico (TCE), daño cerebral adquirido, delirium o agitación psiquiátrica aguda.
Marco Temporal y Tiempo	Evaluación retrospectiva de un periodo de observación clínica (habitualmente un turno de 8 h o una sesión). Tiempo de llenado: 3 a 5 min.
Estructura y Formato	14 ítems conductuales operativos calificados mediante escala tipo Likert de 4 grados (1 = Ausente a 4 = Extremo).
Estatuto de Licencia / Acceso	Dominio público clínico y de investigación (<i>The Ohio State University TBI Network</i>). Instrumento abierto de libre uso asistencial sin regalías.

2. FUNDAMENTACIÓN NEUROBIOLÓGICA DE LA AGITACIÓN AGUDA

La agitación psicomotriz tras daño cerebral traumático (TCE) o en estados confusionales agudos representa un estado fisiopatológico transitorio durante la recuperación del coma o la salida de la Amnesia Postraumática (APT) (Corrigan & Bogner, 1994).

Desconexión Córtico-Subcortical:

- **Lesión Frontal Ventromedial y Orbitofrontal:** Pérdida del control inhibitorio superior sobre conductas automáticas de escape o defensa.
- **Desinhibición Amigdalina:** Respuesta exagerada de alarma ante estímulos sensoriales habituales, generando conductas agresivas reactivas.
- **Amnesia Postraumática (APT):** La incapacidad para consolidar memorias continuas provoca desorientación profunda, perplejidad y miedo.

Desregulación de Neurotransmisores:

- **Tormenta Dopaminérgica y Noradrenérgica:** Hiperactividad adrenérgica central en el sistema reticular ascendente, induciendo hiperalerta motora.
- **Déficit Colinérgico Agudo:** Compromiso en las vías basales de Meynert, factor neuroquímico clave común en el delirium agudo.
- **Sobrecarga Sensorial:** Incapacidad de filtrado atencional talámico ante el ruido y las demandas del entorno hospitalario.

3. ESTRUCTURA TRIFACTORIAL DE LA ABS (14 ÍTEMS CONDUCTUALES)

Factor Clínico	Ítems Asignados	Manifestaciones Conductuales Específicas Evaluadas
I. DESINHIBICIÓN (Inquietud / Impulsividad)	Ítem 1 (Lapsos de atención) Ítem 2 (Inquietud motora) Ítem 6 (Distraibilidad) Ítem 7 (Acciones repetitivas) Ítem 8 (Desinhibición social) Ítem 9 (Retirarse tubos/vías) Ítem 10 (Deambular/escapar)	Falta de focalización en tareas; hiperactividad motora constante en cama o sillón; conversación o risa inadecuada para el contexto; intentos impulsivos de quitarse fijaciones médicas; deambulación insegura o impulsos de fuga.
II. AGRESIVIDAD (Hostilidad Física/Verbal)	Ítem 3 (Amenazas verbales) Ítem 4 (Vociferar / gritar) Ítem 5 (Agresión física) Ítem 14 (Autolesión)	Hostilidad verbal, insultos o maldiciones; gritos o gemidos intensos; golpes, patadas o mordiscos dirigidos a cuidadores u objetos; amenazas a la integridad física del propio paciente o personal.
III. LABILIDAD (Inestabilidad Afectiva)	Ítem 11 (Fluctuación rápida) Ítem 12 (Llanto o risa súbita) Ítem 13 (Tolerancia nula)	Cambios abruptos de ánimo en minutos; episodios de llanto o júbilo desprovistos de desencadenante suficiente; cólera súbita ante frustraciones mínimas o peticiones sencillas del equipo asistencial.

4. CRITERIOS DE GRADACIÓN OPERATIVA Y PUNTUACIÓN DE CADA ÍTEM

Cada ítem se califica del **1 al 4** considerando la frecuencia, severidad y necesidad de intervención del equipo de salud para contener la conducta durante el periodo de observación:

Grado / Valor	Intensidad	Definición Operativa Estándar	Respuesta del Paciente a la Intervención
Puntuación 1	Ausente	El comportamiento evaluado no se observó en ningún momento durante el periodo.	Comportamiento basal cooperador o funcional.
Puntuación 2	Leve	Se presenta de forma ocasional o intermitente con intensidad moderada-baja.	El paciente redirige su atención fácilmente o se calma ante una indicación verbal simple.
Puntuación 3	Moderado	Se presenta de forma frecuente o persistente; interfiere con el cuidado.	Requiere intervención verbal continua, cambio ambiental o supervisión individualizada estrecha.
Puntuación 4	Extremo	Se presenta de forma continua o violenta; representa riesgo lesional inminente.	No cede ante redirección verbal; requiere contención de seguridad física o farmacológica.

5. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA, PUNTOS DE CORTE Y PAUTAS DE ACTUACIÓN

Nivel Clinimétrico	Puntuación Total	Estado Clínico y Significación	Pautas Asistenciales y Seguridad
Normal / No Agitado	14 a 21 puntos	Ausencia de agitación clínicamente significativa o inquietud menor esperable.	Manejo hospitalario ordinario, fisioterapia y estimulación cognitiva habitual.
Agitación Leve	22 a 28 puntos	Inquietud motora o desinhibición verbal leve que no pone en riesgo líneas médicas.	Reducción de ruidos, iluminación suave, orientación frecuente y apoyo familiar.
Agitación Moderada	29 a 35 puntos	Conductas disruptivas continuadas, interferencia con monitoreo y tratamiento.	Supervisión de enfermería 1:1, fijación segura de vías, considerar farmacoterapia leve.
Agitación Severa	36 a 56 puntos	Violencia física extrema, autoagresión inminente, riesgo asistencial grave.	Protocolo de emergencia, medidas de seguridad intensiva y sedación/contención pautada.

6. PROTOCOLO DE MONITORIZACIÓN LONGITUDINAL POR TURNOS

La ABS no debe utilizarse como una medición estática aislada, sino como un **registro longitudinal dinámico** que se califica al final de cada turno hospitalario (Mañana, Tarde, Noche):

1. Detección Temprana de Fluctuaciones: Permite documentar el fenómeno de *sundowning* (empeoramiento vespertino/nocturno) típico del delirium y daño cerebral.

2. Marcador de Resolución de APT: Un descenso mantenido por debajo de 22 puntos durante 48 h consecutivas predice la finalización de la fase agitada de la Amnesia Postraumática.

3. Evaluación de Eficacia Terapéutica: Cuantifica objetivamente si las medidas ambientales o el ajuste psicofarmacológico (betabloqueantes, antipsicóticos) están dando resultado.

4. Prevención de Contenciones Innecesarias: Proporciona justificación objetiva para retirar sujeciones mecánicas tan pronto el puntaje desciende a rango leve/normal.

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESCALONADA

Paso 1: Detección y Calificación Turno a Turno: Puntuación ≤ 21 (Manejo estándar); 22 a 28 (Iniciar Nivel I); 29 a 35 (Activar Nivel II); ≥ 36 (Activar Nivel III de Emergencia).

Paso 2: Intervención Escalonada:

- **Nivel I (Ambiental/Sensorial):** Habitación individual, luz tenue, presencia familiar tranquilizadora, orientación temporal repetida.
- **Nivel II (Protección y Fármacos Leves):** Retirar objetos peligrosos, supervisión estrecha 1:1, manoplas de seguridad, propranolol oral.
- **Nivel III (Emergencia Asistencial):** Alerta a equipo médico, contención física proporcional por tiempo limitado y antipsicóticos atípicos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO CON RESOLUCIÓN PASO A PASO

Presentación: Varón de 26 años, TCE cerrado severo (Glasgow = 7) con contusiones bifrontales, en fase de amnesia postraumática. En turno de tarde forcejea, grita y tira de la sonda vesical.

Puntuación ABS: Desinhibición = **19** (ítems 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10); Agresividad = **8** (ítems 3, 4, 5, 14); Labilidad = **7** (ítems 11, 12, 13). **Total ABS = 34 / 56 puntos (Agitación Moderada).**

Resolución: Habitación individualizada sin estímulos, manoplas de protección para evitar retirada de vía/sonda y propranolol a dosis bajas. Descenso a 20 puntos a las 48 h.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD, PAUTAS ÉTICAS Y DEBER DE PROTECCIÓN

ALERTAS CLÍNICAS Y DE SEGURIDAD:

- Puntuación ≥ 36 (Agitación Severa) implica riesgo crítico de auto/heteroagresión, arrancamiento de vías arteriales o catéteres centrales; requiere presencia médica inmediata.
- **Principio de Proporcionalidad:** Agotar siempre medidas verbales y ambientales antes de contenciones. Revisar contención mecánica cada 2 horas y suspender en cuanto ABS < 29 .

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Corrigan, J. D. (1989). Development of a scale for assessment of agitation following traumatic brain injury. *J Clin Exp Neuropsychol*, 11(2), 261–277.
- Corrigan, J. D., & Bogner, J. A. (1994). Factor structure of the Agitated Behavior Scale. *J Clin Exp Neuropsychol*, 16(3), 386–392.
- Bogner, J. A., et al. (2001). Rating scale analysis of the Agitated Behavior Scale. *J Head Trauma Rehabil*, 16(6), 517–531.
- Shah, A., Evans, H., & Parkash, N. (1998). Evaluation of three aggression/agitation behaviour rating scales. *Int J Geriatr Psychiatry*, 13(6), 415–420.